Ley 20.201 – Decreto 170/2009

Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Vicente Esteban Urbina Calderón				Sexo	F	M X
Fecha Nacimiento	25-09-2026	Edad actual	años	meses	País natal:	Chile	
Domicilio actual:	Calle campo nuevo 4479 Bicentenario Los Ángeles				Teléfono	945773320	
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☐ habla ☒ lee ☐ escribe ☐				
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☒ habla ☒ lee ☐ escribe ☐				
Escolaridad actual:	Kinder B	Establecimiento	Liceo Mixto Basico 2				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 10-03-2026	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Ramiro Urbina Lizama	Nombre:
Relación con el/la estudiante: Padre	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 10-03-2026	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Gabriela Marchant A.	Nombre:
Rol/cargo: Ed. Diferencial	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Cambio de diagnóstico (RGD) por Trastorno del Espectro Autista.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☐ Sí (especificar)

Pediatría: x consultorio	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional:
Neurología: x Los Angeles x sospecha de autismo.	Otro:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☐ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☒ cesárea (señalar motivo) 38 Semanas Programado

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☐ SI ☐ NO	Peso: 3,800	Talla: 49

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

Todo normal en el embarazo.

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	No ✓	Traumatismos	Sí	No ✓	Encefalitis	Sí	No ✓
Obesidad	Sí	No ✓	Intoxicación	Sí	No ✓	Meningitis	Sí	No ✓
Fiebre alta	Sí	No ✓	Enfermedad respiratoria	Sí	No ✓	Otra(s)		
Convulsiones	Sí	No ✓	Asma	Sí	No ✓			
Hospitalizaciones	Sí	No ✓	Especifique motivos y duración:					

Se realizaron controles periódicos de salud	Sí ✓	No		Vacunas	Si ✓	No

Observaciones:

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 5m	Se sienta sólo/a: 7m | 8m	Camina sin apoyo: 1a, 6m
Primeras palabras: 1a	Primeras frases: 2a	Se viste solo/a: El papá lo ayuda
Controla esfínter vesical Diurno: _____ Nocturno: 2a, 6m		Controla esfínter anal Diurno: _____ Nocturno: 2a, 6m

Observaciones:

En su actividad motora general se aprecia:
☒ normal ☐ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia:
☒ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	Sí ✓	No	Caídas frecuentes	Sí	No ✓	Dominancia lateral Utiliza ambas manos	Sí	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	Sí ✓	No	Prensión	Sí ✓	No	Pinza ✓	Sí	No
Ensarta	Sí ✓	No	Dibuja	Sí ✓	No	Escribe	Sí	No ✓

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	Sí ✓	No	Manipula y Explora objetos	Sí ✓	No
Demanda objetos y compañía	Sí ✓	No	Comprende prohibiciones	Sí ✓	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	Sí ✓	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Si	No ✓

Observaciones:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.3. Visión - Audición:					
Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	Sí	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño) A veces	Sí	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	No	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	No
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	No	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No
Observaciones:					

5.4. Desarrollo del Lenguaje					
El niño (a) se comunica preferentemente en forma ☑ oral ☐ gestual ☐ mixto ☐ otro (especifique):					
Características del lenguaje expresivo					
Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí	No	Emite/produce frases	Sí	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	No	Relata experiencias	Sí	No
Emite palabras/produce señas	Sí	No	La emisión/pronunciación/producción es clara + o -	Sí	No
Características del lenguaje comprensivo					
Identifica objetos	Sí	No	Sigue instrucciones simples	Sí	No
Identifica personas	Sí	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	No
Comprende conceptos abstractos	Sí	No	Sigue instrucciones grupales	Sí	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí	No
Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos): NO					
Observaciones:					

5.5. Desarrollo Social					
Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	No	Respeta normas sociales	Sí	No
Participa en actividades grupales	Sí	No	Respeta normas escolares	Sí	No
Opta por trabajo individual	Sí	No	Muestra sentido del humor	Sí	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	No	Movimientos estereotipados	Sí	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	No	Pataletas frecuentes	Sí	No
Ante los siguientes estímulos su reacción es:					
Luces: ☑ natural ☐ desmesurada	**Sonidos:** ☐ natural ☐ desmesurada		**Personas extrañas:** se presenta normal ☐ natural ☐ desmesurada		
Observaciones: mas que conoce a los personas.					

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante					
Vacunas al día	Sí	No	Trastorno motor	Sí	No
Epilepsia	Sí	No	Problema bronco-respiratorio	Sí	No
Problemas cardiacos	Sí	No	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	No
Paraplejia	Sí	No	Trastorno emocional	Sí	No
Pérdida auditiva	Sí	No	Trastorno conductual	Sí	No
Pérdida visual	Sí	No	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique):

Alimentación: ☐ normal ☐ "malo/a" para comer ☒ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☒ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☒ normal ☐ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme: 9 hrs.

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos
☐ sonambulismo ☐ despierta de buen humor

Duerme: ☐ solo ☒ acompañado
(Especifique): con el papá o hermana

Humor/comportamiento ***(señale el comportamiento habitual)***

☐ alegre ☐ juguetón/bromista ☐ risueño(a) ☒ triste ☐ serio ☒ rebelde ☒ apático ☒ violento(a)
Otro:

Observaciones: * presenta selectividad alimenticia (Fideos, carne, pollo, Nuggett, Fruta, banano, papas fritas, Hamburguesa)

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.				
Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Ramiro Urbina	papá	41	4° medio	comerciante
2. Mayli Urbina	Hermana	16	Estudiante	Liceo.
3.				
4. (El papá tiene	la custodia	de ambos	hijos,	
5. se encuentran	en un	tema	Judicial)	
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia
(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):
Observaciones:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	2a	Asistió a jardín infantil: sala de estimulación / en cordel sano	Sí X	No
Nº de colegios en que ha estudiado	2	Modalidad de enseñanza Regular ☐ Especial ☐ Técnica ☐:		
Motivo de los cambios: cambio de la ciudad de Los Angeles a Los Andes				
Ha repetido curso/s	Sí	No X	Curso(s)	Motivo: —

Situación actual

Nivel/curso actual	KB		**Dificultad de aprendizaje**	Sí ✓	No	**Dificultad para participar**	Sí	No ✓	**Conducta disruptiva**	Sí	No ✓
Asiste regularmente	Sí	No ✓	Asiste con agrado	Sí ✓	No	Apoyo familiar en tareas	Sí ✓	No	Amigos (as) en el colegio	Sí	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?

☐ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?

☐ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?

☐ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....

Especifique el tipo de refuerzos o premios:

☐ expresiones afectivas ☐ alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?

☐ madre ☐ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales .....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?

☐ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?

☐ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

- Presenta interes por el baile, la musica, los autos, los camiones.
- Inventa juegos con la policia.
- No consume medicamentos.
- No le gusta tomar pastillas.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY